

- Brandt, M.** (2013). Intergenerational help and public assistance in Europe. *European Societies*, 15, 26–56.
- Cantillon, B., Van Lancker, W.** (2013). Three shortcomings of the social investment perspective. *Social Policy and Society*, 12, 553–564.
- Carmichael, F., Charles, S.** (1998). The labour market costs of community care. *Journal of Health Economics*, 17, 747–765.
- European Commission** (2013). „Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and that Committee of the Regions”, Towards Social Investment for Growth and Cohesion-including implementing the European Social Fund 2014–2020. COM(2013) 83.
- Heitmueller, A.** (2007). The chicken or the egg? Endogeneity in labor market participation of informal carers in England. *Journal of Health Economics*, 26, 536–559.
- Johnson, R., Lo Sasso, A.** (2000). The trade-off between hours of paid employment and time assistance to elderly parents at midlife. The Urban Institute working papers.
- Myrdal, A., Gunnar, M.** (1934). Kris i befolkningsfrågan. Stockholm: Albert Bonniers Förlag.
- OECD.** (2005). The OECD health project: Long-term care for older people. Paris: OECD.
- Perkins, D., Nelms, L., Smyth, P.** (2004). Beyond neo-liberalism: the social investment state? Social Policy Working Paper No 3, Brotherhood of St Laurence.
- PriceWaterhouseCoopers.** (2009). Hoolduskoormuse vähendamiseks jätkusuutliku eakate hooldussüsteemi finantseerimissüsteemi väljatöötamine.
- Tarum, H.** (2013). Poliitikaraamistiku ja poliitikakujundajate toetus mitteformaalselt eakaid hooldavate inimeste tööturul osalemisele. Magistritöö, Tartu Ülikool.

Omastehooldus kui Eesti hoolekandesüsteemi vundament



Ivar Paimre

juhatuse liige, MTÜ Eesti Omastehooldus

Eesti sotsiaalkaitseüsteemi üks aluspõhimõte on isiku ja perekonna omavastutus. See tähendab, et esmane vastutus oma heaolu, sotsiaalse ja majandusliku toimetuleku ning inimväärse elu kindlustamisel on inimesel ja tema perekonnal.

Omastehooldajad on igas vanuses inimesed, kes hooldavad enamasti tasuta ning väljaspool professionaalset või formaalset hoolekandesüsteemi oma pereliiget või lähedast, kes vajab

haiguse, puude või muu erivajaduse tõttu abi igapäevastes toimingutes.

Heaolu arengukava rõhutab uue sotsiaalse riskina suurenevat hoolduskoormust. Esmane vastutus langeb perekonnale. Pere peab suutma korraldada oma võimaluste ja oskuste juures abi vajava pereliikme hoolduse. Seega on omastehooldajad sisuliselt Eesti hoolekandesüsteemi esimese astme hoolekandetöötajad. Selles situatsioonis, kus vanemaealisi on rahvastiku

osakaalus aina rohkem, suurenevad kõrvalabi vajadus ja hoolduskoormus veelgi. Olukorra leevendamiseks on vaja toetavaid teenuseid ja kvaliteetseid hooldusvõimalusi.

Praegu on omastehooldus mitmel põhjusel ilmse surve all. Esmalt on põhjuseks vähene sündivus ja väiksemad pered. Hoolduskoormust on seetõttu pereliikmete vahel raskem jagada. Vajadus omastehoolduse järele kasvab ka inimeste suureneva mobiilsuse tõttu. Rahvusvahelisis nii õpingutes, tööturul kui ka perekondlikus plaanis toob endaga kaasa lisakohustusi hoolduse korraldamisel ja sellega tuleb saada hakkama hoolimata riigipiiridest.

Üks põhjus on ka naiste aktiivsus tööhõives. Traditsiooniliselt on naistel suurem hoolduskoormus. Veel olulisem põhjus on pikenev tööiga. Aeg, mil tuleb tööhõivet ja hoolduskohustust kombineerida, võib järjest pikeneda. Seda muidugi eeldusel, et omastehooldaja üldse saab ja jaksab ühitada tööd ja hooldust.

Sotsiaalkaitseüsteemi suurimad murekohad on sotsiaalteenuste ja -toetuste ebaühtlane jaotus ja kättesaadavus Eestis ning hooldustöötajate puudus. Samuti

avaldab negatiivset mõju omastehoolduse senine reguleerimatus, pole usaldusväärseid andmed omastehooldajate arvu ja nende hoolduskoormuse kohta. See suurendab omastehooldajate tõrjutuse ohtu.

Heaolu arengukava sihtrühmaks on hoolduskoormusega inimesed, kes on hoolduskohustuse iseloomu tõttu erinevate sotsiaalpoliitika instrumentide mõjuväljas. Hoolduskoormuse vähendamine, toetavate sotsiaalteenuste pakkumine, võrdsete võimaluste loomine tööturul ja soolise ebavõrdsuse vähendamine parandavad omastehooldajate heaolu ning majanduslikku ja sotsiaalset toimetulekut. Kokkuvõttes tähendab see, et kättesaadavad peavad olema asjakohased ja õigeaegsed toetused ja teenused, mis vastavad hoolduskoormuse raskusele ja siduvusele. Eesmärk on parandada omastehooldaja teadlikkust ja turvatunnet, et tugevneks ka enesekindlus hooldamisel.

Omastehooldajate olukorda aitab loodetavasti parandada ka Riigikantslei juurde moodustatud hoolduskoormuse vähendamise rakkerühm, mis alustuseks määratleb hooldusega seotud mõisted. See võib kaasa tuua ka muudatusi heaolu arengukava rakendustes. **S**